

Memoria · Playbook de creación de contenido a medida (Novo Nordisk × WPP Media, 2026)

Fuente: PDF "Novo Nordisk: Bespoke Content Creation Playbook 2026" (Novo Nordisk × WPP Media), 44 páginas en inglés, aportado por la usuaria el 22-09-2026 como "REDES.pdf". **Esta memoria:** traducción íntegra al castellano, página a página. Las páginas que solo contienen capturas de pantalla de ejemplo (7, 18, 20, 21, 32) y la contraportada (44) se indican sin texto. Notas de la traductora entre corchetes [N. T.]. **Última actualización:** 2026-09-22. **Uso:** complementa el Módulo 3 (M3_*): el playbook aporta el "por qué", el tono, la traducción de datos a historias, los cuatro pilares, los formatos, las plataformas y la medición. Donde el playbook y el Módulo 3 se solapan (disclaimers, privacidad, farmacovigilancia), manda el Módulo 3, que es el marco español.

Índice del documento original

Sección	Contenido	Página
01 Los cimientos	Definir tu "por qué" (4-5) · Tono de voz (6-7) · Ética y compliance (8) · Disclaimers (9) · Do's y don'ts (10) · Privacidad del paciente (11) · Fuentes (12)	3-12
02 Traducción	El ángulo personal (14) · Cómo funcionar en pantalla (15-16) · De la estadística a la historia (17-18) · Cómo visualizar datos (19-21) · El A-B-C de cada post (22)	13-22
03 Caja de herramientas	Los cuatro pilares (24-25) · Formatos (26) · Que la ciencia brille con sencillez (27) · Del dato a la historia (28) · Traducción creativa de la ciencia (29) · La IA como herramienta (30) · Estructura del prompt (31-32) · Gestión de comunidad (33)	23-33
04 Las plataformas	Plataformas de un vistazo (35-36) · Elige dos, no siete (37)	34-37
05 Medición	Lo que importa medir (39) · Construir una línea base (40) · Cuándo ajustar (41) · Evaluación y adaptación (42)	38-42
Cierre	Preparada para crear, compartir y conversar (43)	43

SECCIÓN 01 · Los cimientos

Antes del contenido, la claridad.

Definir tu "por qué" (p. 4)

Si no puedes responder a esto en una frase, no publiques todavía.

01 Propósito. ¿Qué cambio quieres provocar? ¿Qué resultado buscas con esta pieza concreta de contenido? ¿Compartir con tus colegas los últimos hallazgos científicos? ¿Dar visibilidad a una enfermedad concreta? ¿Fomentar una conducta saludable específica? ¿Desmontar una idea equivocada muy extendida? ¿Animar a las personas a buscar consejo profesional?

02 Mensaje clave. ¿Cuál es la idea única y más importante que quieres que tu audiencia recuerde? Si olvidaran todo lo demás, ¿qué afirmación central querrías que conservaran? ¿Y puedes comunicar ese punto central con claridad y concisión en una sola frase?

03 Conclusión y llamada a la acción. ¿Qué debería hacer o sentir quien vea tu post? ¿Quieres que tu audiencia haga algo concreto, por ejemplo consultar a su médico, compartir el post, cambiar algo de su alimentación? ¿O que participe en un diálogo científico? ¿Y qué intentas despertar: esperanza, motivación, confianza, capacidad de decidir, sensación de urgencia...?

04 Audiencia. ¿Hablas a pacientes, a colegas o al público? ¿A quién exactamente intentas llegar con este post? ¿Al paciente recién diagnosticado o a los familiares de un joven con exceso de peso? ¿A otros profesionales sanitarios o al público general? Su nivel de conocimiento actual, sus posibles sesgos y sus motivaciones en ese tema concreto son esenciales para definir tu tono y tus mensajes.

05 Canal. ¿Dónde pasa ya su tiempo esa audiencia? Según la audiencia definida, ¿cuál de tus plataformas es la más adecuada para este contenido? ¿LinkedIn para colegas profesionales, X para la actualización rápida y el debate entre pares, Facebook para una comunidad más amplia? ¿Y cuál de los formatos del canal se presta mejor a contar tu historia?

06 Giro personal. ¿Qué hace que esto sea relevante y auténtico precisamente viniendo de ti? ¿Cómo puedes hacerlo tuyo, aportando tu experiencia profesional, tu experiencia clínica o tu perspectiva personal? ¿Qué historia personal (o de paciente, anonimizada) puede ayudarte a poner el mensaje en un contexto auténtico? ¿Y cómo puede el contenido ayudarte a construir confianza como profesional sanitario creíble?

Ejemplos de "por qué" (p. 5)

- **Ejemplo ancla 1:** "Ayudo a las personas que viven con diabetes a entender su enfermedad crónica y cómo pueden vivir de forma más saludable, comunicado de igual a igual y sin tácticas de miedo, en mi canal preferido, Instagram."
- **Ejemplo ancla 2:** "Ayudo a profesionales sanitarios y responsables de políticas a mantenerse al día de la investigación y los avances en el manejo de la diabetes, facilitando estrategias basadas en la evidencia y soluciones colaborativas en LinkedIn."
- **Ejemplo ancla 3:** "Desmonto mitos e ideas erróneas frecuentes sobre la diabetes para un público general, aportando datos rápidos y contrastados y fomentando un diálogo público más informado sobre la salud relacionada con el peso, sobre todo en X."

Tono de voz (p. 6)

Elige un registro y mantenlo durante toda la pieza. Pero recuerda: tu tono fuera de la red es tu mejor tono en la red. ¡No intentes ser otra persona!

#	Tono	En tres palabras	Qué consigue
01	Guía	Tranquilo, estructurado, de profesor.	Te posiciona como mentor que acompaña. Lenguaje claro y lógico que da confianza mediante una orientación clara y explicaciones completas. P. ej., explicar un plan de tratamiento o cómo interpretar unos datos.

#	Tono	En tres palabras	Qué consigue
02	Cercano	Personal, humano, "un día en mi vida".	Te conecta con la audiencia desde la empatía, la comprensión y lo humano. Usa anécdotas personales y experiencias compartidas. Ayuda a que la audiencia se sienta comprendida y menos sola, tendiendo un puente entre el experto y la experiencia vivida.
03	Experto	Directo, guiado por la evidencia, sin suavizar.	Establece tu autoridad y credibilidad mediante la ciencia y la precisión, centrándose en investigación, evidencia y datos. Es el tono crítico para verificar hechos y rebatir la desinformación, presentar investigación nueva o hacer afirmaciones basadas en evidencia clara.
04	Humorístico	Ligero, con autoconciencia, nunca a costa del paciente.	Un humor apropiado y ligero puede hacer más accesibles temas complejos o delicados. Exige autoconciencia y sensibilidad y nunca debe restar seriedad ni minimizar las dificultades del paciente. Hecho con respeto, rompe la tensión e ilustra una idea.
05	Conversacional	Preguntas y respuestas, reactivo, en diálogo.	La conversación en dos direcciones fomenta la participación y la interacción. Lenguaje informal y relajado, preguntas, invitación a comentar: la audiencia se siente escuchada e incluida, y el contenido resulta amable e informativo en lugar de una lección.

Ejemplos de tono de voz (p. 7)

Página de capturas de ejemplo. Texto visible: Guía · Cercano ("personal, humano, un día en mi vida") · Experto ("directo, guiado por la evidencia, sin suavizar") · Humorístico ("muchos cortes rápidos y efectos de zoom") · Conversacional ("efectos visuales llamativos"). **Lo que tienen en común: captan tu atención al instante con un tono a ras de suelo. Muchos empiezan con una pregunta.**

Ética y compliance (p. 8)

No son opcionales. Protegen al paciente, a la profesión y a ti.

Innegociable: - Identifícate siempre brevemente por tu rol y, si procede, tus credenciales. - Todo contenido patrocinado o de marca debe marcarse con claridad con #AD (o su traducción local para "anuncio"/"publicidad") como **primera palabra del texto** y como **rótulo sobre el vídeo**. [N. T.: en España, #publicidad o #publi, según el Módulo 3.] - No diagnosticar ni tratar en los comentarios. - Ninguna historia de paciente sin consentimiento explícito y documentado. - Ninguna afirmación sobre usos de fármacos fuera de ficha técnica (*off-label*). - Citar fuentes para las afirmaciones clínicas (estudio, guía, año). - Declarar las colaboraciones con la industria. - Tener presentes las obligaciones de farmacovigilancia cuando se publiquen acontecimientos adversos en internet.

Disclaimers que deben ir en cada post (p. 9)

Tipo	Texto
General	"Información general, no consejo médico."
Derivación (referral)	"Consulta a tu propio profesional sanitario para las decisiones individuales."
Patrocinado	"PUBLICIDAD de [marca]" o "AD de [marca]".

En vídeo: colocar el disclaimer en el texto del post y en pantalla durante los tres primeros segundos (la marca de publicidad debe verse durante todo el vídeo).

[N. T.: las plantillas literales en castellano están en `M3_tres_disclaimers.md`.]

Do's y don'ts (p. 10)

SÍ	NO
Habla en lenguaje llano.	Responder a síntomas con diagnósticos.
Muestra tu razonamiento, no solo tus conclusiones.	Usar imágenes, voces o historias de pacientes sin consentimiento.
Corrígete en público cuando te equivoques.	Publicar entornos hospitalarios identificables sin permiso.
Cita la fuente de forma visible.	Atacar a nadie.
Quédate en tu especialidad.	Prometer resultados ("esto curará...").
¡Sé tú!	Usar música, imágenes, vídeos u otros materiales con derechos (informes médicos, publicaciones) para los que no tengas permiso o licencia explícitos.

Privacidad del paciente (p. 11)

La regla: si una sola persona puede reconocerse, el post es demasiado específico.

Tres comprobaciones antes de publicar: 1. ¿Podrían el paciente, su familia o un colega identificar el caso? 2. ¿Hay algo en el plano (historia, pantalla, tarjeta identificativa...) que identifique? 3. ¿Has anonimizado los detalles clínicos lo suficiente como para que pudiera ser cualquier paciente?

[N. T.: es la regla "una sola persona" de `M3_regla_una_sola_persona.md`.]

Fuentes (p. 12)

Toda afirmación clínica debe ser rastreable. 1. Nombre del estudio o de la guía. 2. Año. 3. Visible en el texto del post o en la tarjeta final.

Si no puedes citarlo, no lo digas.

SECCIÓN 02 • Traducción

La habilidad no es saber más. Es hacer que llegue.

El ángulo personal (p. 14)

El usuario medio de redes sociales dedica menos de un segundo a tu publicación. Por eso tienes que maximizar tu impacto. **Para que te recuerden, tienes que ser personal.**

- **Usa el "yo" al contar.** "Lo que les digo a mis pacientes el primer día es..."

- **Áncalo en momentos cotidianos.** La cocina, salir a correr, distintos lugares: no solo la consulta.
- **Muestra, no enumeres.** Grábate haciendo aquello que explicas.
- **Comparte hallazgos frescos.** Grábate en los pasillos de un congreso: "Estoy en el congreso XX y acabo de aprender que..."

La prueba: ¿podría leer esto cualquiera con un guion, o tiene que ser tú?

Cómo funcionar en pantalla: vídeo (p. 15)

1. Mira al objetivo, no a la pantalla.
2. Siéntate o ponte de pie con energía.
3. Abre con una persona, no con un tema.
4. Varía el ritmo: frena en la frase clave.
5. Sé auténtica, no excesivamente promocional.
6. Usa un gancho fuerte para captar la atención en todo tu contenido, de los reels a los textos.
7. Termina con una idea, no con una despedida.

Cómo funcionar en pantalla: imagen estática (p. 16)

1. Usa un gancho visual potente.
2. Un solo mensaje central por imagen.
3. Prioriza la sencillez y la claridad visual.
4. Usa imágenes centradas en personas o analogías reconocibles.
5. Contextualiza los datos y la información compleja en un escenario cercano.
6. Escribe un texto fuerte y conciso, con una llamada a la acción clara.
7. Recuerda citar tus fuentes de forma visible.

De la información estadística a una historia que engancha (p. 17)

01 Contar historias con datos - Identifica el mensaje central y su relevancia para tu audiencia. - Enmarca el dato en una narrativa (problema, hallazgo, solución). - Conecta los números con su impacto real o con ejemplos humanos.

02 Explicar datos complejos - Simplifica el lenguaje y evita la jerga para que lo entienda más gente. - Usa analogías y comparaciones para que el dato resulte cercano. - Céntrate en el "por qué importa", no solo en la cifra bruta.

03 Visualizar hallazgos - Elige gráficos claros y sencillos (gráficas, infografías) fáciles de digerir. - Prioriza el impacto visual y destaca los hallazgos clave con eficacia. - Asegúrate de que el diseño sea limpio, con tu identidad y optimizado para redes.

Ejemplos (p. 18)

Página de capturas: un carrusel de redes como ejemplo de las tres técnicas. Sin texto adicional.

Cómo visualizar datos (p. 19)

Tres formatos que funcionan para contenido clínico: 1. **Comparación.** Antes y después, con y sin, mito y realidad. 2. **Secuencia.** Qué pasa en la semana 1, el mes 1, el año 1. 3. **Escala.** Compáralo con algo que conocemos de nuestro cuerpo o de la vida diaria.

Evita: gráficos de tarta en 3D, tablas densas, cualquier cosa que necesite zoom.

Ejemplos de visualización en LinkedIn e Instagram (pp. 20-21)

Páginas de capturas. Sin texto traducible.

El A-B-C de cada post (p. 22)

	Momento	Elemento	Qué hacer
A	Los primeros 3 segundos	El gancho	Haz una promesa, plantea una pregunta, nombra una tensión. Entrega tu mensaje clave pronto en el texto.
B	El medio	El concepto	Un mensaje, un foco: sencillo y claro. Que a tu audiencia le resulte fácil entender la conclusión. Si tienes más que decir, divídelo en varios posts.
C	Los últimos 3 segundos	La conclusión	Diles qué hacer, pensar o recordar. Pide a tu audiencia una sola cosa cada vez (clic en el enlace de la bio, comentar, ver un vídeo). Pedir demasiado suele acabar en que no hagan nada.

Si falta cualquiera de los tres, el post no está terminado.

SECCIÓN 03 · Caja de herramientas de contenido

Pilares, formatos y el ritmo de producción.

Los cuatro pilares de contenido (p. 24)

01 Desmontar mitos. "Has oído X. La verdad es Y. Te explico por qué." Identifica y desmonta ideas erróneas, desinformación o creencias desfasadas. Aporta hechos claros y basados en evidencia para poner las cosas en su sitio y dar a tu audiencia información precisa que le ayude a orientarse en un mundo de consejos contradictorios. *Construye confianza, aclara la confusión y te posiciona como fuente fiable.*

02 Ciencia desentrañada. Arrojar luz sobre hallazgos científicos y desgranarlos para tu audiencia. Según hables a tu vecino o a tus colegas, simplificarás la investigación compleja con analogías y explicaciones claras, o profundizarás en matices, metodologías y lecturas críticas. Se trata de hacer accesible el conocimiento avanzado y de destacar tu pericia como fuente creíble.

03 Preguntas y respuestas. Responde a las preguntas que de verdad te hacen en consulta o tus colegas: son las mismas que la gente escribe en el buscador. Aborda directamente las dudas, preocupaciones o curiosidades de tus pacientes o seguidores. Consiste en escuchar a tu audiencia, dar respuestas directas y respaldadas por evidencia, y fomentar una conversación en dos direcciones que construya comunidad y confianza. *Atiende preocupaciones reales y crea conexiones directas.*

04 ¿Sabías que...? Un dato sorprendente, bien documentado, que se gana un guardado o un compartido. Comparte hechos, estadísticas y hallazgos poco conocidos que llamen la atención, despierten curiosidad y entreguen información valiosa y memorable capaz de cambiar una perspectiva. *Capta la atención con píldoras educativas rápidas y compartibles.*

Ejemplos de los cuatro pilares (p. 25)

Desmontar mitos · Infografía. Pantalla dividida o gráfico claro: "Solo fuerza de voluntad" (tachado) frente a "Biología compleja y entorno" (marcado). Texto: "Mito desmontado: 'La obesidad es solo cuestión de fuerza de voluntad'. Muchos creen que la obesidad es una simple elección, pero la ciencia revela un cuadro mucho más complejo, con genética, hormonas y factores ambientales. Entenderlo nos ayuda a abordar el tratamiento con empatía y eficacia."

Preguntas y respuestas · Vídeo corto. Un profesional sanitario hablando a cámara: "Una de las preguntas más frecuentes de mis pacientes es '¿qué efectos secundarios tienen los medicamentos GLP-1?'. Aunque en general se toleran bien, algunas personas tienen náuseas, diarrea o estreñimiento, sobre todo al inicio del tratamiento. Suelen mejorar con el tiempo. Y lo más importante: consulta siempre a tu profesional sanitario para un consejo personalizado."

Ciencia desentrañada · Carrusel. Cinco tarjetas que simplifican la ciencia de los medicamentos GLP-1: portada, tres tarjetas con los mecanismos clave y una tarjeta final de llamada a la acción. "Desentrañando el GLP-1: cómo funcionan estos medicamentos en el manejo del peso. 1) La ciencia del GLP-1. 2) Ralentiza la digestión. 3) Reduce los antojos. 4) Tu camino hacia la salud." Texto pequeño: "Juntos, estos efectos sostienen un nuevo enfoque del manejo del peso. Habla siempre con tu profesional sanitario para saber si es adecuado para ti."

¿Sabías que...? · Post estático. Gráfico de un globo terráqueo o un grupo diverso de personas con el texto: "El coste económico global de la obesidad podría equivaler a más de 500 dólares por cada persona del planeta, cada año." Texto: "*¿Sabías que el impacto económico global de la obesidad podría alcanzar los 4,32 billones de dólares anuales en 2035, más de 500 dólares por cada habitante de la Tierra, cada año? Este coste enorme afecta a todo, desde los sistemas sanitarios hasta la economía de cada familia. Entenderlo ayuda a comprender por qué abordar bien la obesidad nos importa a todos.* World Obesity Federation, 2023."

[N. T.: los ejemplos con GLP-1 hablan de la clase farmacológica, no de marcas. En España, las siete líneas rojas del Módulo 3 siguen vigentes: principio activo o clase, nunca nombre comercial, y disclaimer de derivación.]

Formatos de contenido: qué usar y cuándo (p. 26)

Formato	Duración	Para qué	Dónde
Vídeo corto	15-60 s	Ganchos, desmontar mitos, consejos rápidos. Máximo alcance, consumo rápido, mayor viralidad.	Instagram, YouTube, X, TikTok
Vídeo largo	3-10 min	Explicaciones en profundidad, tutoriales, paso a paso. Lo mejor para confianza y educación.	YouTube, Facebook, LinkedIn
Post estático	1 imagen	Una afirmación fuerte, una cita o una infografía. Impacto inmediato. Ideal para guardar y compartir.	X, Facebook, Instagram, LinkedIn

Formato	Duración	Para qué	Dónde
Carrusel	5-10 tarjetas	Paso a paso, antes y después, listas. Lo mejor para educar y explicar.	Instagram, Facebook, LinkedIn, X
Directo de preguntas	En vivo	Construir confianza, temas de actualidad. Sesiones interactivas en tiempo real.	Instagram, Facebook, YouTube
Entrevista / debate	Variable	Credibilidad entre pares y amplitud. Conversaciones con otros expertos, pacientes o líderes de opinión.	YouTube, LinkedIn, Facebook

Una mezcla de trabajo: 30 % post estático · 25 % carrusel · 25 % vídeo corto · 10 % vídeo largo · 10 % directo o entrevista.

Que la ciencia brille con sencillez (p. 27)

Las reglas de oro de la visualización de datos en redes: 1. **Un mensaje central por imagen.** No sobrecargues. ¿Cuál es la única conclusión más importante de este dato? 2. **Gana la sencillez.** Evita el desorden. Menos suele ser más para un consumo rápido. 3. **El contexto manda.** Explica siempre qué significa el dato y por qué importa. 4. **Cita la fuente.** Indica siempre con claridad de dónde sale el dato.

Del dato a la historia (p. 28)

Los números no mueven a las personas. La forma del número, sí.

Clínico	Humano
El 30 % de los adultos	1 de cada 3 personas que conoces
Reduce el riesgo un 25 %	Tres de cada cuatro siguen con el mismo riesgo
HbA1c del 7,2 %	Más o menos lo que tiene la mayoría de pacientes bien controlados
Ensayo con 4.200 pacientes	Evidencia del tamaño de un pueblo entero

Recuerda siempre a tu audiencia. Si hablas a colegas, conviene un lenguaje más científico y clínico. Si te diriges al usuario general de redes, explícalo en un tono mucho más humano y cercano.

Ejemplos creativos de traducción científica (p. 29)

Maneras rápidas y prácticas de dar vida a tus hallazgos dejando que lo visual amplifique tu mensaje (¡sin sustituirlo!).

Recurso	Qué es	Ejemplo
La tarjeta destacada	Visualmente distinta, fácil de leer, centrada en el impacto.	"Casi 3 de cada 4 pacientes lograron X pérdida de peso en el estudio Y. Fuente: [revista, año]."
El gráfico sencillo	Los tipos de gráfico familiares se entienden fácilmente.	Gráfico de barras que compara "HbA1c basal" con "HbA1c a los 6 meses con el tratamiento X".
El desglose rápido	Divide información compleja en trozos	Carrusel de 3 tarjetas con "Hallazgos clave del último estudio sobre diabetes publicado en <i>NEJM</i> ", un hallazgo por tarjeta.

Recurso	Qué es	Ejemplo
	digeribles e invita a participar.	
El antes y después	Intuitivo para mostrar impacto, progreso o elección.	Dos siluetas idénticas, una con el texto "–15 % de peso corporal". O "Opción A frente a Opción B" con viñetas a cada lado resumiendo resultados.
La analogía visual	Una foto de banco pertinente hace el dato más cercano y memorable.	Una planta creciendo para "beneficios de salud a largo plazo", con una cifra como "X % menos de riesgo".
La encuesta o pregunta rápida	Muy participativa, despierta curiosidad y prepara a la audiencia para tu dato.	"¿Cuál es tu mayor obstáculo para mantener la pérdida de peso a largo plazo? Hambre o antojos constantes · Comer por emociones o estrés · Falta de energía o motivación · Recuperar peso a pesar del esfuerzo. ¡Tu experiencia importa! Vota: la semana que viene entramos en la ciencia de por qué estos retos son tan comunes."

[N. T.: el "antes y después" con cifras de peso es un ejemplo del original; en publicidad de servicios sanitarios en España evitar promesas de resultado (RD 1907/1996). Válido para divulgar resultados de estudios con fuente, no para vender una consulta.]

La IA como herramienta de trabajo (p. 30)

No sustituye tu criterio. Acelera el trabajo alrededor, arranca ideas y facilita la lluvia de ideas.

Úsala para	No la uses para
Redactar variantes de gancho.	Generar afirmaciones clínicas que no hayas verificado.
Simplificar y reescribir lenguaje clínico y ciencia compleja.	Consejo específico de paciente o diagnóstico.
Convertir viñetas en esquemas de guion.	Interactuar directamente con pacientes o darles apoyo.
Resumir estudios que ya has leído.	Generar ideas que carezcan de tu voz y tu perspectiva.
Encender ideas y ángulos nuevos cuando te sientas "atascada".	Escribir como tú, sin tocarlo.

Prompting: la estructura en seis partes (p. 31)

Prompt débil: "Escríbeme un post sobre el manejo de la diabetes."

Un prompt fuerte tiene seis partes: 1. **Rol.** "Eres un endocrinólogo británico interesado en comunicar novedades científicas a la comunidad de profesionales sanitarios." 2. **Tarea.** "Crea un post de LinkedIn (texto e imagen) que resuma lo más destacado del congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) 2025." 3. **Audiencia.** "Para profesionales sanitarios interesados en tratamientos de la diabetes y novedades científicas." 4. **Fuente.** "Basa tu respuesta en los hallazgos clave del último congreso de la EASD 2025." 5. **Conclusión buscada.** "El lector debe sentirse informado, inspirado y más al día de las novedades científicas en el manejo de la diabetes." 6. **Restricciones.** "Ten en cuenta que la audiencia es sobre todo sanitaria, así que podemos mantener el lenguaje clínico y el tono."

Cuanto más específicas las restricciones, más utilizable el resultado.

Prompting con IA: el resultado tangible (p. 32)

Página de captura: ejemplo de post generado ("Endocrinólogo, St Thomas' Hospital"). Sin texto adicional.

Gestión de comunidad (p. 33)

En el día a día cuesta priorizar la gestión de comunidad. Pero si encuentras el tiempo, te ayudará a construir y cuidar tu comunidad.

1. Responde a las preguntas en menos de 24 horas cuando sea posible; también para frenar la propagación de la negatividad.
2. **Alcance orgánico y visibilidad:** una comunidad activa y comprometida comparte tu contenido y aumenta de forma orgánica tu visibilidad y alcance.
3. Fija arriba la mejor pregunta y respóndela.
4. Bloquea, no discutas, a las cuentas de mala fe.
5. Guarda las preguntas frecuentes: son el contenido de la semana que viene.
6. **Ventaja competitiva:** una comunidad fuerte y comprometida puede ser lo que te distinga de la competencia.
7. **Nunca diagnostiques en los comentarios:** redirige a "habla con tu médico".

SECCIÓN 04 • Las plataformas

Donde vive el mensaje. Y qué aspecto debe tener allí.

Plataformas de un vistazo (pp. 35-36)

Plataforma	Para qué sirve	Audiencia	Contenido que funciona
Instagram	Traducir ciencia compleja en contenido visual atractivo y conclusiones rápidas, consejos de salud, desmontar mitos, tras las cámaras.	Amplia y mixta, algo más joven.	Infografías, explicaciones en vídeo corto (reels), preguntas y respuestas (stories, directos), datos rápidos, ideas de recetas saludables, consejos de ejercicio, historias de pacientes (con consentimiento y anonimización adecuada), "un día en mi vida".
Facebook	Facilitar y cuidar comunidades en torno a la diabetes y el manejo del peso, compartir piezas educativas más largas, directos de preguntas, llegar a un público amplio y diverso.	Amplia y consolidada, algo mayor.	Artículos educativos, directos, encuestas a la comunidad, promoción de eventos (webinars, charlas locales), avances científicos simplificados, enlaces a recursos externos fiables, testimonios de pacientes.
LinkedIn	Conversar con colegas, compartir visión profesional, difundir investigación, construir liderazgo de	Profesionales sanitarios, investigadores, industria,	Resúmenes de artículos científicos, conclusiones de congresos, artículos

Plataforma	Para qué sirve	Audiencia	Contenido que funciona
	opinión en el sector sanitario, debatir políticas o práctica clínica.	responsables de políticas, gestores.	de opinión sobre tendencias, debates sobre guías clínicas.
X	Noticias y actualizaciones en tiempo real, cobertura en directo de congresos, hallazgos rápidos, corregir desinformación con datos concisos, debates inmediatos (#MedTwitter, #DiabetesTwitter).	Periodistas, responsables de políticas, investigadores, sanitarios, pacientes que buscan novedades rápidas y público que sigue hashtags de salud.	Noticias de investigación, tuits en directo desde congresos, datos rápidos, enlaces a artículos y estudios más largos.
Substack	Publicar artículos largos, boletines y análisis en profundidad; construir una relación directa con una base de suscriptores muy implicada; ser dueña de tu contenido y tu audiencia.	Nichos, algo mayores, muy implicados, que buscan opinión experta y explicaciones completas.	Boletines, análisis a fondo, casos clínicos, opinión, resúmenes de literatura científica, lecturas recomendadas.
TikTok	Aprovechar tendencias creativas para dar información sanitaria precisa y basada en evidencia de forma muy atractiva y compartible; vídeos rápidos que traducen datos complejos a contenido accesible y entretenido.	Joven, guiada por tendencias.	Datos "¿sabías que...?", vídeos mito o realidad, consejos rápidos de vida saludable, demostraciones visuales, explicaciones breves de mecanismos de enfermedad, afirmaciones positivas, contenido motivacional.
YouTube	Educación con autoridad y basada en evidencia mediante vídeos largos, explicaciones detalladas, series de educación al paciente, entrevistas con expertos, datos científicos en formato visual accesible.	Amplia y mixta, que busca información y formación.	Entrevistas, explicaciones detalladas, tutoriales, resúmenes de ensayos clínicos, preguntas y respuestas con expertos, módulos de educación al paciente, lo mejor de los congresos, revisiones de literatura.

No estés en todas partes. Elige las que encajan contigo.

[N. T.: "historias de pacientes" y "testimonios de pacientes" aparecen en el original para Instagram y Facebook. En España, testimonios de pacientes con fin promocional de un servicio sanitario están prohibidos por el RD 1907/1996; la vía segura es el arquetipo compuesto del Módulo 3.]

Elige dos. No siete (p. 37)

La mayoría de los profesionales sanitarios fracasan por intentar estar en todas partes. Elige por audiencia y por tu punto fuerte.

Enfoque	Pareja	Por qué
Centrado en pacientes	Instagram + TikTok	Alto alcance, visual, conversacional.
Centrado en colegas	LinkedIn + X	Autoridad experta, impacto en tiempo real.
Autoridad mixta	YouTube + Instagram	Biblioteca + alcance. Lo mejor para la marca a largo plazo.

Elige donde puedas ser constante durante al menos seis meses.

SECCIÓN 05 • Medición

Qué seguir. Qué ignorar.

Las mediciones que importan (p. 39)

- **Alcance.** ¿Te están viendo? Número de usuarios únicos: cuántas personas distintas han visto tu contenido.
- **Interacción.** ¿Está llegando? Nivel de interacción y participación con tu contenido; se mide con me gusta, comentarios, compartidos y clics.
- **Sentimiento.** ¿Cómo te reciben? ¿Tu contenido se percibe positivo, negativo o neutro? Se mide en comentarios, preguntas, mensajes privados, etc.

Construir una línea base (p. 40)

No puedes mejorar si no mides. 1. **Establece.** Publica con constancia. No hagas cambios. Registra todo. 2. **Diagnostica.** Identifica tus tres mejores y tus tres peores posts. Busca el patrón. 3. **Afina.** Identifica lo que funciona y haz más de eso. Deja de hacer lo que no funciona.

Qué medir: alcance · interacción · comentarios · impresiones · me gusta · compartidos · guardados.

¿Cuándo ajustar el contenido? (p. 41)

Señales de alarma ante las que actuar: - La interacción cae durante 4 semanas o más pese a publicar con constancia. - Los comentarios se vuelven más negativos con el tiempo o se van del tema. - Cae el alcance o las impresiones. - No llegan seguidores o suscriptores nuevos. - El contenido de colegas y perfiles parecidos al tuyo funciona claramente mejor.

Evaluación y adaptación continuas (p. 42)

La evaluación y la adaptación continuas son cruciales para tu éxito. Al revisar tu estrategia de redes cada mes puedes identificar y sustituir rápidamente lo que no funciona e implantar ideas nuevas y más eficaces que te acerquen a tus objetivos. Este enfoque dinámico e iterativo garantiza que tu estrategia siga siendo relevante, eficaz y alineada con tus objetivos generales.

Cierre • Preparada para crear, compartir y conversar (p. 43)

Ya has recorrido los principios básicos de la creación de contenido personal, auténtico, ético y atractivo: - **Definir tu propósito:** tu "por qué" único y tu voz auténtica. - **Sostener la ética:** cómo moverte en compliance, privacidad y comunicación responsable. - **Traducir ciencia y datos:** cómo transformar datos complejos en historias convincentes y cercanas. - **Usar pilares, formatos y plataformas:** cómo emplear los distintos tipos de contenido para dar vida a tus historias, adaptadas a la audiencia relevante. - **Conversar con tu comunidad:**

cómo cultivar la confianza y la participación de tus seguidores. - **Impulsar el crecimiento y la confianza:** cómo evaluar el impacto para seguir aprendiendo y adaptándote.

Ahora tienes las herramientas y la capacidad para compartir tu conocimiento vital en los canales digitales. **Da el paso, deja tu huella e inspira el cambio.**

(p. 44: contraportada, sin texto.)

Cómo encaja con el Módulo 3 (mapa cruzado)

Playbook	Módulo 3
Ética y compliance (p. 8), disclaimers (p. 9)	M3_marco_legal_etico_compliance.md (7 líneas rojas, P3), M3_tres_disclaimers.md
Do's y don'ts (p. 10)	M3_dos_y_donts_posting.md
Privacidad del paciente (p. 11)	M3_regla_una_sola_persona.md
Farmacovigilancia (p. 8, última línea)	M3_marco_legal_etico_compliance.md (P2, protocolo RAM en 3 pasos)
Fuentes (p. 12), A-B-C (p. 22), pilares (p. 24), IA (p. 30), prompt de seis partes (p. 31)	M3_protocolo_creacion_reels_posts.md (fases guion y producción)